EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 77805
SERVICIO : MEL MUJERES HSC
FECHA : 2024-01-23 12:13:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CHRISTOPHER LEONARDO SAN MARTIN MARDONES			RUN	: 22.831.318-1
F.Nac	: 16-09-2008	Edad	: 15 AÑOS, 4 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: PORTAL DEL SUR F CAMIROAGA 55			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-01-16	Fecha Egreso	: 2024-01-23 12:13:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. G61.0-SINDROME DE GUILLAIN-BARRE

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Sd Guillain Barre. Variante AMAN

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. G61.0-SINDROME DE GUILLAIN-BARRE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes mórbidos:
- Asma
Antecedentes quirúrgicos:
- Sin antecedentes
Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos
Medicamentos:
- Cetirizina
- Budesonida 2 puff cada 12 horas
- Salbutamol 2 puff SOS
Antecedentes familiares:
- Sin antecedentes familiares sospechosos de polineuropatia hereditaria
- Sin antecedentes de enfermedades autoinmunes
- Sin antecedentes oncológicos
- Sin antecedente de muertes inexplicadas
Habitos:
- OH: (-)
- Tabaco: (-)
- Drogas (-)
Social:
- Ultima vacunacion en 2022 SARS CoV2

Diestro mRS 0
Paciente sin antecedentes sospechosos de compresión facil. Sin antecedentes de cuadros infecciosos previo al inicio del cuadro actual, sin diarrea, sin exposición a medicamentos/tóxicos, sin sintomas sospechosos de alteraciones tiroideas. Sin dolor lumbar previo a inicio de síntomas. Consulta el 15/1/24 en APS por cuadro de paraparesia de 2 día de evolución asociado a alteraciones sensitivas, niega síntomas esfinterianos.
Refiere haber iniciado el 13/01/24 cuadro consistente inicialmente en parestesias plantar bilateral asociado progresivamente a hipoestesia en calcetin ascendente durante el día. Al domingo con alteración de la marcha por debilidad inicial en dorsiflexión de pie y posteriormente extensión rodilla y flexión de cadera, mas a derecha por lo que deciden consultar. Sin presencia de síntomas bulbares.

Niega presencia de alteraciones miccionales o defecatorios. Se describe al examen paraparesia e hipoestesia en ambas EEII por lo que se derivó a HSC.
Ingresa con bradicardia leve sin otras alteraciones en signos vitales (FC 55 lpm, PA 112/52 mmHg, T° 36.5°C, Sat 97, HGT 97). Se hospitaliza para evaluación por neurología, no se realizó estudio de LCR ni presentación a UPC por SU.
Se toma conocimiento del caso el 16/01/24, paciente en buenas condiciones. Realizo PL para estudio de LCR con trocar N25 bajo tecnica esteril y anestesia local al primer intento sin inconvenientes, se rescatan 8 frascos de 1 cc para estudio y guardar. HGT concomitante 96 mg/dL.
Estudio complementario con LCR transparente, incoloro. Gluc 59, Prot 39, Lactato 1.1, Alb 12.9, Gram sin bacterias. 16/01/24 Proteinas plasm 7.0, Alb 4.2, CK 70, P 3.8, C3 89, C4 15.5, Mg 1.9. TSH 3.052, T4L 1.25, VitB12 178, VitD 15.7. HIV (-), RPR (-), HBV (-), HCV (-)
Se realizó EEF con EMG y VCN con resultado concordante con proceso polineuropatico predominio motor sin actividad aguda actual y asociado a bloqueos de conduccion proximal sin alteracion de respuestas tardias, lo cual es compatible con AMAN en etapa inicial. Se inició terapia con IVIG en dosis de 0.4g/Kg/día por 5 días sin inconvenientes y con regresión progresivo lento y parcial del déficit.
Se mantiene hospitalización para favorecer rehabilitación. Se conversa con madre y se acuerda en conjunto continuar rehabilitación por hospitalización domiciliaria.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido. Cambios de posición cada 3-4 horas.
2. Régimen común.
3. Budesonida 2 puff cada 12 horas con aerocámara
4. Salbutamol 2 puff SOS con aerocámara
5. Pargeverina gotas, 20 gotas SOS en caso de dolor abdominal.
6. Kinesioterapia motora
7. Terapia ocupaciona
8. Control CAE neurología al alta.
9. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 18/01/24 ANA (-), perfil ENA (-), ANCA (-), MPO (-), PR3 (-), antiDNA (-)
- 16/01/24 TC de columna cervico dorsal: sin alteraciones
- 16/01/24 LCR transparente, incoloro. Gluc 59, Prot 39, Lactato 1.1, Alb 12.9, Gram sin bacterias.
- 16/01/24 Proteinas plasm 7.0, Alb 4.2, CK 70, P 3.8, C3 89, C4 15.5, Mg 1.9. TSH 3.052, T4L 1.25, VitB12 178, VitD 15.7. HIV (-), RPR (-), HBV (-), HCV (-)
- 16/01/24 Glic 135, Alb 4.4, Creat 0.7, Uremia 23, BUN 11, ELP 140/4.2/105, Ca+2 9.1, Hb 14.4, Hto 43.1, Leuco 10.000, plaq 330.000. Lactato 1.8. AU 4.5. BT/BD 0.5/0.16, GOT/GPT/GGT 29/17/16, FA 153. INR 1.12. TTPa 32. ColT 132, TGL 115. FR (-), ASO menor 200.

OBSERVACIONES:

Al momento del alta
Al examen general:
SV T° 36.3, FC 58 lpm, PA 111/55 mmHg, Sat 97% amb
- Bien hidratado, bien perfundido. Sin lesiones en piel
- Cardiaco RR2T no logro auscultar soplos
- MP + SRA
- Abdomen BDI RHA+
- EEII sin edema, sin signos de TVP

Al examen neurológico:
- Mental normal.
- NC pupilas isocóricas, RFM +/+ CV normal. OCM normal. sensibilidad facial simétrica, facie y mueca simétrica, pares bajos normal. Conteo 35, sin cefaloparesia
- Motor: EESS a izquierda extensión muñeca M4-, resto M5. EEII flexión cadera M4+, extensión rodilla M4, dorsiflexión M2 y flexión plantar M1. ROT EEII solo presente patelar derecho. Resto arreflexia. Plantares indiferentes.
- Sensitivo hipopalestesia leve EEII
- Coordinacion normal.
- Signos meningeos negativos

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO